CADEAU 2 / 5 · DIENSTPAKKET

Gids voor beeldinterpretatie

Eén pagina per onderzoek, zodat je niets overslaat: waar je eerst naar kijkt, waar je daarna naartoe gaat en wat je controleert voordat je de beoordeling afrondt.

Inhoud

Hoe gebruik je deze gids

Röntgen: PA-thoraxfoto · Bedside AP-thoraxfoto · Laterale thoraxfoto · Staande buikoverzichtsfoto · Röntgenfoto pols · Röntgenfoto heup / bekken · Röntgenfoto knie · Röntgenfoto enkel · Röntgenfoto cervicale wervelkolom

CT: CT-hersenen (trauma) · CT-hersenen (CVA) · CT-thorax · CT-pulmonalisangiografie · CT abdomen-bekken · Total body CT bij trauma · CT-nierstenenprotocol

MRI: MRI-hersenen · MRI lumbale wervelkolom · MRI-knie

Echo en doppler: Echo abdomen (bovenbuik) · Echo nieren-blaas · eFAST · Longecho · Veneuze duplex onderste extremiteit

Volgende stap

OM TE BEGINNEN

Hoe gebruik je deze gids

Lijsten van één pagina per onderzoek, zodat je ze snel op je telefoon kunt raadplegen: 24 onderzoeken, elk op een eigen pagina.

> *Open de bijbehorende pagina voordat je het onderzoek opent. Volg de drie blokken in volgorde en begin het verslag met de sjabloonzin.*

Elke pagina bestaat uit dezelfde vier blokken

1 · Vooraf

Voorbereiding en kwaliteit: juiste patiënt, juist onderzoek, technische kwaliteit, eerdere onderzoeken. Stap **VOORBEREIDEN** van de methode.

2 · Daarna

Genummerde volgorde van doorlopen. Kijk elke keer in dezelfde volgorde; stop niet bij de eerste bevinding. Stappen **DOORLOPEN** en **BESCHRIJVEN** van de methode.

3 · Voordat je afsluit

Checklist van de vaakst gemiste plekken en rode vlaggen die je direct moet melden. **Vergelijk** en **SAMENVATTEN**.

Sjabloonzin voor het verslag

Een skelet dat je aanpast aan je eigen bevindingen. Vul de vierkante haken (**[rechts/links]**, **...**) in; verwijder de zin die niet past.

Gebruik op je telefoon

Sla de pdf op je telefoon op en ga via de inhoudsopgave naar het onderzoek. Elk onderzoek beslaat één pagina en is van begin tot eind te lezen zonder te scrollen.

Onthoud

Zie je een rode vlag, wacht dan niet tot het verslag af is: meld het eerst aan je supervisor en de behandelaar, en zet de melding daarna met tijdstip in het verslag.

PA-thoraxfoto

Röntgen *Pijn op de borst, kortademigheid, koorts en hoesten bij een ambulante patiënt, en preoperatieve beoordeling.*

1 · Vooraf

- Controleer patiëntnaam, datum, zijdemarkering en projectie (PA als de scapulae buiten de longvelden liggen).
- Rotatie: liggen de mediale uiteinden van de claviculae op gelijke afstand van de processus spinosi?
- Inspiratie: in de midclaviculaire lijn moeten ongeveer 6 voorste of 9–10 achterste ribben zichtbaar zijn.
- Penetratie: de wervels moeten achter de hartschaduw vaag zichtbaar zijn.
- Open de vorige opname; vergelijken is je sterkste instrument.

2 · Daarna

1. **Luchtweg:** trachea in de middenlijn?, carina en hoofdbronchi.
2. **Mediastinum en hili:** breedte, contour, densiteit en hoogte van de hili.
3. **Hart:** cardiothoracale ratio, contouren.
4. **Longen:** doorloop de boven-, midden- en ondervelden en vergelijk rechts met links.
5. **Pleura:** sinus phrenicocostales, pleuralijn langs de thoraxwand.
6. **Diafragma:** contour, vrij lucht onder het diafragma, maagluchtbel.
7. **Botten en weke delen:** ribben, claviculae, schouders, mammaschaduwen, subcutaan emfyseem.
8. **Tubes, katheters en devices.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Longtoppen (achter de overlap van ribben en clavicula).
- [ ] Hili en achter het hart (retrocardiale ruimte).
- [ ] Onder en achter de diafragmakoepels.
- [ ] Ribben één voor één (fractuur, lytische laesie).
- [ ] Oksel en weke delen van de mamma (mastectomie, massa).

Rode vlaggen · direct melden

Spanningspneumothorax · vrij lucht onder het diafragma · verbreed mediastinum · verkeerd liggende tube/katheter.

Sjabloonzin voor het verslag

PA-thoraxfoto: Technisch voldoende. Trachea in de middenlijn. Cardiothoracale ratio binnen normale grenzen. Mediastinum en hili zonder bijzonderheden. Geen actieve consolidatie of massa in beide longen. Sinus phrenicocostales vrij. Geen vrij lucht onder het diafragma. Afgebeelde ossale structuren zonder bijzonderheden. Conclusie: Geen actieve longpathologie.

Bedside AP-thoraxfoto

Röntgen *Patiënt op de IC, verpleegafdeling of SEH; controle van tubes en katheters en klinische verslechtering.*

1 · Vooraf

- Noteer projectie en positie: AP, liggend of halfzittend (vocht en lucht verzamelen zich op een andere plek).
- Op een AP-opname lijken hart en mediastinum groter; beoordeel de cardiothoracale ratio niet.
- Rotatie en inspiratie zijn vaak beperkt; vermeld de technische beperking in het verslag.
- Leg de vorige bedside-opname altijd naast de huidige: de eigenlijke vraag is hier «wat is er veranderd?».

2 · Daarna

1. **Eerst tubes en lijnen:** Tip van de ETT (ten opzichte van de carina), maagsonde (onder het diafragma in de maag?), tip van de CVC (distale VCS / cavoatriale overgang), thoraxdrain, pacemakerdraden.
2. **Pneumothorax:** bij een liggende patiënt verzamelt lucht zich anterieur en caudaal; deep sulcus-sign, scherpe hart- en diafragmacontour.
3. **Effusie:** diffuse wazige densiteitstoename, apicale kap.
4. **Longen:** oedeem, consolidatie, atelectase (vooral de linker onderkwab achter het hart).
5. **Mediastinum en hart:** verbreding ten opzichte van de vorige opname.
6. **Onder het diafragma** en **weke delen** (subcutaan emfyseem).

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Heb je de tip van elke tube en lijn afzonderlijk gevonden?
- [ ] Achter het hart en de linker onderkwab.
- [ ] Sinus phrenicocostales (deep sulcus).
- [ ] Longtoppen.
- [ ] Staat alles wat nieuw is ten opzichte van de vorige opname in het verslag?

Rode vlaggen · direct melden

ETT in hoofdbronchus of oesofagus · maagsonde in de luchtweg · nieuwe pneumothorax na een ingreep · tekenen van spanning.

Sjabloonzin voor het verslag

Bedside AP-thoraxfoto (halfzittende positie). Vergeleken met het vorige onderzoek (datum). Tip van de ETT … cm boven de carina. Tip van de CVC in de distale VCS. Tip van de maagsonde onder het diafragma, in de maag. Geen pneumothorax. […] Ten opzichte van het vorige onderzoek [toegenomen/afgenomen/onveranderd].

Laterale thoraxfoto

Röntgen *Lokalisatie van een verdachte bevinding op de PA-opname, verborgen pathologie in de onderkwab en het mediastinum.*

1 · Vooraf

- Lees samen met de PA-opname; de laterale opname wordt niet los beoordeeld.
- Armen omhoog, inspiratie voldoende?
- Bepaal welke zijde het dichtst bij de cassette lag en onderscheid de twee hemidiafragma's (het voorste deel van de linker koepel wordt door het hart uitgewist, de maagluchtbel ligt onder de linker koepel).

2 · Daarna

1. **Retrosternale ruimte:** moet radiolucent zijn (opvulling: anterieure mediastinale massa).
2. **Retrocardiale ruimte:** moet radiolucent zijn.
3. **Wervels:** moeten naar caudaal toe radiolucenter worden; lijken de onderste thoracale wervels opaker, denk dan aan onderkwabpathologie.
4. **Hili** en longarteriën.
5. **Fissuren:** major en minor; verdikking, verplaatsing.
6. **Dorsale sinus phrenicocostales:** een kleine effusie is hier het eerst zichtbaar.
7. **Trachea** en luchtweg.
8. **Sternum en thoracale wervelkolom:** hoogte van de wervellichamen, compressiefractuur.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Retrosternale en retrocardiale ruimte.
- [ ] Dorsale sinus phrenicocostales.
- [ ] Hoogte van de thoracale wervellichamen.
- [ ] In welke kwab/welk segment de bevinding van de PA-opname op de laterale opname valt.

Rode vlaggen · direct melden

Retrosternale opvulling (anterieure mediastinale massa) · wervelinzakking · onderkwabconsolidatie die op de PA-opname verborgen blijft.

Sjabloonzin voor het verslag

PA- en laterale thoraxfoto: [...]. Op de laterale opname zijn de retrosternale en retrocardiale ruimte vrij. Dorsale sinus phrenicocostales vrij. Hoogte van de thoracale wervellichamen behouden.

Staande buikoverzichtsfoto

Röntgen *Buikpijn, verdenking obstructie, verdenking perforatie, radio-opake concrementen en corpus alienum.*

1 · Vooraf

- Staand of liggend? Vloeistofspiegels zijn alleen zichtbaar op een staande opname of een decubitusopname.
- Vallen het diafragma en de symfyse binnen het beeld?
- Bij verdenking op vrij lucht is een staande thoraxfoto gevoeliger; bij een patiënt die niet kan staan linkerzijligging (decubitus) of CT.
- Eerdere onderzoeken en operatieve voorgeschiedenis.

2 · Daarna

1. **Vrij lucht:** onder het diafragma, Rigler-sign, football-sign op een liggende opname.
2. **Darmgasverdeling:** dunne darm (centraal, valvulae conniventes) en colon (perifeer, haustra); kaliber (vuistregel 3-6-9 cm).
3. **Vloeistofspiegels:** aantal en verdeling.
4. **Gas in het rectum** aanwezig?
5. **Tekenen van volvulus:** reusachtige darmlis in de vorm van een omgekeerde U die uit het bekken opstijgt (koffieboon).
6. **Verkalkingen:** nier–verloop van de ureter–blaas, galblaas, pancreas, vaten.
7. **Wekedelenschaduwen:** contouren van lever, milt en psoas.
8. **Botten:** wervels, bekken, heupen.
9. **Tube, stent en corpus alienum.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Onder het diafragma en de longbases.
- [ ] Bekken (verwar flebolieten niet met concrementen; volg het verloop van de ureter).
- [ ] Herniapoorten (darmgas in de liesregio).
- [ ] Botten (lytische/sclerotische laesie).
- [ ] Gas in de darmwand (pneumatosis) of vertakkend gas in de lever.

Rode vlaggen · direct melden

Vrij lucht · sigmoïd- of coecumvolvulus · uitgesproken colondilatatie (verdenking toxisch megacolon) · pneumatosis of gas in de v. portae.

Sjabloonzin voor het verslag

Staande buikoverzichtsfoto: Geen vrij lucht onder het diafragma. Niet-specifieke darmgasverdeling. Geen pathologische vloeistofspiegels. Geen densiteit passend bij een radio-opaak concrement in het verloop van de urinewegen. Afgebeelde ossale structuren zonder bijzonderheden.

Röntgenfoto pols

Röntgen *Polspijn na een val, deformiteit, drukpijn in de tabatière anatomique.*

1 · Vooraf

- Minstens twee orthogonale projecties (PA en lateraal); bij verdenking op een scafoïdfractuur een scafoïdserie.
- Zijn de zijdemarkering en het gevraagde gebied in beeld?
- Is de laterale opname echt lateraal (radius en ulna over elkaar)?
- Bij een kind: noodzaak om de groeischijven met de andere zijde te vergelijken.
- Klinische vraag: plaats van de puntdrukpijn.

2 · Daarna

1. **Weke delen:** zwelling, vervaging van de pronator-vetlijn.
2. **Distale radius:** corticale continuïteit, gewrichtsvlak, angulatie op de laterale opname.
3. **Ulna** en processus styloideus ulnae.
4. **Carpalia:** drie vloeiende carpale bogen (bogen van Gilula).
5. **Scafoïd:** vooral de taille.
6. **Op de laterale opname de lijn radius–lunatum–capitatum:** lunatum- en perilunaire luxatie.
7. **Metacarpalia**, falanxen en gewrichtsspleten.
8. **Botstructuur:** osteopenie, lytische laesie.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Scafoïd.
- [ ] Processus styloideus ulnae.
- [ ] Carpale bogen en, op de laterale opname, het lunatum.
- [ ] Basis en hals van het vijfde metacarpale.
- [ ] Randen van de opname.

Rode vlaggen · direct melden

Lunatum- of perilunaire luxatie · verdenking open fractuur (lucht in de weke delen) · gedisloceerde intra-articulaire fractuur · klinisch verdacht scafoïd met normale röntgenfoto.

Sjabloonzin voor het verslag

PA- en laterale opname van de [rechter/linker] pols: Fractuurlijn in de distale radiusmetafyse, [met/zonder] uitbreiding naar het gewrichtsvlak, met [dorsale/volaire] angulatie. Carpale alignment behouden. Geen fractuurlijn in het scafoïd; bij aanhoudende klinische verdenking controle-opname of aanvullende beeldvorming geadviseerd.

Röntgenfoto heup / bekken

Röntgen *Heuppijn na een val bij een oudere patiënt, niet kunnen belasten, bekkentrauma.*

1 · Vooraf

- AP-bekken en laterale opname van de betreffende heup.
- Rotatie: zijn de foramina obturata en de bekkenschoepen symmetrisch?
- Vallen de hele bekkenring en de proximale femora binnen het beeld?
- Voorgeschiedenis van prothese, implantaat of oude fractuur.

2 · Daarna

1. **Bekkenring:** bekkenschoepen, rami pubis en ischii, breedte van de symfyse, sacro-iliacale gewrichten (de ring breekt meestal op twee plaatsen).
2. **Acetabulum:** iliopectineale en ilio-ischiadische lijn.
3. **Femurkop:** contour en gewrichtsspleet.
4. **Collum femoris:** lijn van Shenton, continuïteit van de trabekels, corticale onderbreking, sclerotische band bij een impactiefractuur.
5. **Trochanters:** intertrochantaire en subtrochantaire regio.
6. **Contralaterale heup** ter vergelijking.
7. **Sacrum:** arcuate lijnen.
8. **Weke delen** en implantaten.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Rami pubis en ischii.
- [ ] Sacrum en sacro-iliacale gewrichten.
- [ ] Contralaterale heup.
- [ ] Subtrochantaire regio (pathologische of atypische fractuur).
- [ ] Randen van de opname en de onderste lumbale wervels.

Rode vlaggen · direct melden

Gedisloceerde collumfractuur · bekkenringfractuur met diastase van symfyse of SI-gewricht (bloedingsrisico) · heupluxatie · verdenking pathologische fractuur.

Sjabloonzin voor het verslag

AP-bekken en laterale opname van de [rechter/linker] heup: In de [rechter/linker] collum femoris is een [subcapitale/transcervicale] fractuurlijn zichtbaar; de lijn van Shenton is [onderbroken/intact]. Geen fractuur van de bekkenring. Contralaterale heup zonder bijzonderheden.

Röntgenfoto knie

Röntgen *Knietrauma, hydrops, niet kunnen belasten; degeneratieve pijn.*

1 · Vooraf

- AP en lateraal; zo nodig axiale patella-opname of schuine opnamen.
- Is de laterale opname echt lateraal (femurcondylen over elkaar)?
- Is de laterale opname met horizontale stralengang gemaakt (alleen dan is een vet-vloeistofspiegel zichtbaar)?
- Traumamechanisme.

2 · Daarna

1. **Suprapatellaire effusie op de laterale opname.**
2. **Lipohemartros:** vet-vloeistofspiegel bij horizontale stralengang → intra-articulaire fractuur.
3. **Tibiaplateaus:** vooral het laterale plateau; corticale step-off en densiteitstoename.
4. **Femurcondylen.**
5. **Patella:** fractuurlijn, hoogte.
6. **Fibulakop.**
7. **Avulsiefragmenten:** een klein fragment aan de laterale tibiarand (Segond) wijst op bandletsel.
8. **Gewrichtsspleten,** osteofyten, chondrocalcinose.
9. **Weke delen.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Effusie en vet-vloeistofspiegel op de laterale opname.
- [ ] Tibiaplateau (subtiele fracturen).
- [ ] Fibulakop.
- [ ] Kleine avulsiefragmenten.
- [ ] Fossa intercondylaris (los corpus).

Rode vlaggen · direct melden

Lipohemartros · knieluxatie (risico op letsel van de a. poplitea) · gedisloceerde plateaufractuur · open fractuur.

Sjabloonzin voor het verslag

AP- en laterale opname van de [rechter/linker] knie: Fractuurlijn met impressie van het laterale tibiaplateau. Op de laterale opname met horizontale stralengang een vet-vloeistofspiegel in de recessus suprapatellaris (lipohemartros). Congruentie van het kniegewricht behouden.

Röntgenfoto enkel

Röntgen *Enkelpijn na verzwikking of val, drukpijn op de malleoli, niet kunnen belasten.*

1 · Vooraf

- AP-, mortise- (lichte endorotatie) en laterale opnamen.
- Valt de basis van het vijfde metatarsale binnen het beeld? Zo niet en bij klinische verdenking: röntgenfoto van de voet.
- Zijdemarkering en plaats van de wekedelenzwelling.

2 · Daarna

1. **Weke delen:** zwelling rond de malleoli.
2. **Malleolus lateralis (fibula):** niveau van de fractuur ten opzichte van de syndesmose.
3. **Malleolus medialis.**
4. **Malleolus posterior:** achterrand van de tibia op de laterale opname.
5. **Mortise:** is de gewrichtsspleet overal even breed (mediale clear space)?
6. **Taluskoepel:** osteochondrale laesie.
7. **Op de laterale opname de calcaneus** en processus van de talus.
8. **Basis van het vijfde metatarsale.**
9. **Distale tibiofibulaire syndesmose.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Malleolus posterior.
- [ ] Taluskoepel.
- [ ] Basis van het vijfde metatarsale.
- [ ] Calcaneus en processus lateralis tali.
- [ ] Kans op een hoge fibulafractuur bij een fractuur van de malleolus medialis (afhankelijk van de kliniek; zo nodig opname van het hele onderbeen).

Rode vlaggen · direct melden

Verstoorde mortise of verplaatsing van de talus · trimalleolaire fractuur · luxatiefractuur · open fractuur.

Sjabloonzin voor het verslag

AP-, mortise- en laterale opname van de [rechter/linker] enkel: Schuine fractuurlijn in de malleolus lateralis ter hoogte van de syndesmose. Malleolus medialis en posterior intact. Congruentie van de mortise behouden.

Röntgenfoto cervicale wervelkolom

Röntgen *Laagrisico-nektrauma, nekpijn; bij hoogrisicotrauma is CT het eerste onderzoek.*

1 · Vooraf

- Op de laterale opname moet de overgang C7–T1 zichtbaar zijn; zo niet, dan is de opname onvoldoende.
- AP- en open-mondopname (dens).
- Opname met halskraag; de beslissing om de immobilisatie op te heffen wordt niet op basis van jouw verslag genomen.
- Beweging en overprojectie van de schouders: vermeld de technische beperking.

2 · Daarna

1. **Alignment:** de anterieure en posterieure wervellijn, de spinolaminaire lijn en de toppen van de processus spinosi moeten vloeiende bogen vormen.
2. **Botten:** hoogte van de wervellichamen, posterieure elementen, processus spinosi.
3. **Dens en C1–C2:** atlantodentale afstand.
4. **Discusruimten** en facetgewrichten.
5. **Prevertebrale weke delen:** verbreding wijst op trauma of infectie.
6. **Afstand tussen de processus spinosi:** waaiervormig uiteenwijken wijst op bandletsel.
7. **AP- en densopname:** processus spinosi in de middenlijn, laterale massa's van C1 symmetrisch.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Overgang C7–T1.
- [ ] Basis van de dens.
- [ ] Prevertebrale weke delen.
- [ ] Congruentie van de facetgewrichten.
- [ ] Craniocervicale overgang.

Rode vlaggen · direct melden

Malalignment · facetluxatie · prevertebrale zwelling · densfractuur → immobilisatie handhaven en CT adviseren.

Sjabloonzin voor het verslag

Laterale, AP- en open-mondopname van de cervicale wervelkolom: Op de laterale opname zijn de wervels van C1 tot en met T1 beoordeeld. Alignment behouden. Wervellichaamhoogten zonder bijzonderheden. Breedte van de prevertebrale weke delen normaal. Geen acute fractuur.

CT-hersenen (trauma)

CT *Schedeltrauma, veranderd bewustzijn, val bij een patiënt met antistolling.*

1 · Vooraf

- Onderzoek zonder contrast.
- Open het hersen-, subdurale (brede) en botvenster elk afzonderlijk.
- Dunne-coupe botreconstructies; coronale en sagittale MPR.
- Bewegingsartefacten; klinische informatie: EMV, antistolling, plaats van de klap.

2 · Daarna

1. **Extra-axiaal:** epidurale en subdurale collecties (rond de schedel in het subdurale venster), langs falx en tentorium.
2. **Subarachnoïdaal:** cisternen, sulci, cisterna interpeduncularis.
3. **Intraparenchymateus:** contusie (frontale en temporale basis), hematoom.
4. **Intraventriculaire bloeding.**
5. **Massa-effect:** midline shift, toestand van de basale cisternen, herniatie (subfalcine, uncale, tonsillaire).
6. **Ventrikelgrootte.**
7. **Botvenster:** calvarium, schedelbasis, os temporale, orbita en aangezichtsschedel.
8. **Extracraniaal:** schedelhuidhematoom (plaats van de klap en tegenover), vocht in sinussen en mastoïd, pneumocephalus.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Vertex (dun subduraal hematoom op coronale reconstructie).
- [ ] Langs het tentorium en in de fossa posterior.
- [ ] Onder het schedelhuidhematoom en aan de tegenovergestelde zijde (contrecoup).
- [ ] Schedelbasis en os temporale.
- [ ] Afgebeelde bovenste cervicale wervelkolom.

Rode vlaggen · direct melden

Hematoom met massa-effect · herniatie · verstreken basale cisternen · impressiefractuur · open fractuur of pneumocephalus.

Sjabloonzin voor het verslag

Blanco CT-hersenen: Geen intracraniële bloeding. Middenlijnstructuren in de middenlijn. Ventrikelsysteem en cisternen zonder bijzonderheden. Grijze-wittestofdifferentiatie behouden. In het botvenster geen fractuur van calvarium of schedelbasis. Hematoom van de [linker pariëtale] schedelhuid. Conclusie: Geen acute intracraniële pathologie.

CT-hersenen (CVA)

CT *Plotseling ontstaan neurologisch deficit, CVA-protocol.*

1 · Vooraf

- Vraag naar het tijdstip van ontstaan van de symptomen.
- Eerst een blanco CT; gebruik het CVA-venster (smal venster).
- Bevat het protocol CT-angiografie en perfusie?
- De eerste en belangrijkste vraag: is er een bloeding?

2 · Daarna

1. **Bloeding:** intracerebraal, subarachnoïdaal, subduraal — bij bloeding is de ischemieroute gesloten; meld direct.
2. **Hyperdens-arteriesign:** ACM en a. basilaris, vergeleken met de andere zijde.
3. **Vroege tekenen van ischemie:** verlies van het insulair lint, vervaging van de nucleus lentiformis, verlies van de grijze-wittestofdifferentiatie, verstreken sulci.
4. **ASPECTS:** als je instelling het gebruikt: scoor regio voor regio in het stroomgebied van de ACM.
5. **Fossa posterior:** hersenstam en cerebellum (kijk ondanks artefacten).
6. **Oude infarcten** en small vessel disease.
7. **Wat op een CVA lijkt:** tumor, subduraal hematoom.
8. **Als er een CTA is:** occlusie van een groot vat (ACI, M1, M2, a. basilaris), carotisbifurcatie, collateralen.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Is het hyperdense vat aan beide zijden vergeleken?
- [ ] A. basilaris en cerebellum.
- [ ] Op de CTA de aortaboog en de halsvaten.
- [ ] Longtoppen binnen het CTA-veld.

Rode vlaggen · direct melden

Bloeding · occlusie van een groot vat → direct naar het CVA-team · uitgebreide vroege ischemie.

Sjabloonzin voor het verslag

Blanco CT-hersenen (CVA-protocol): Geen intracraniële bloeding. Vroege ischemische tekenen in het stroomgebied van de [rechter/linker] ACM [aanwezig/afwezig]; ASPECTS: … . Hyperdens-ACM-sign [aanwezig/afwezig]. CTA: occlusie van het M1-segment van de [rechter/linker] ACM […]. Bevinding om … uur doorgegeven aan het CVA-team.

CT-thorax

CT *Massa of nodus, infectie, interstitiële longziekte, niet-traumatische thoracale pathologie.*

1 · Vooraf

- Met of zonder contrast, welke fase?
- Vensters: long, mediastinum (weke delen), bot.
- Dunne coupes; MIP voor noduli.
- Open de vorige CT (groeitijd van een nodus is cruciaal).

2 · Daarna

1. **Longvenster — luchtwegen:** van de trachea tot de segmentale bronchi.
2. **Longvenster — parenchym:** nodus, consolidatie, matglas, interstitiële afwijkingen, emfyseem.
3. **Pleura en fissuren:** effusie, verdikking, pneumothorax.
4. **Mediastinumvenster:** hart, pericard, aorta en a. pulmonalis, lymfeklieren, oesofagus, schildklier.
5. **Thoraxwand,** oksel en mamma.
6. **Afgebeelde bovenbuik:** lever, bijnieren, milt, bovenpolen van de nieren.
7. **Botvenster:** wervels, ribben, sternum (fractuur, lytische of sclerotische laesie).

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Centrale luchtwegen (endobronchiale laesie).
- [ ] Longtoppen en sinus phrenicocostales.
- [ ] Achter het hart en paravertebraal.
- [ ] Bijnieren.
- [ ] Botten en schildklier.

Rode vlaggen · direct melden

Incidentele longembolie · aortadissectie of -aneurysma · pneumothorax · massa die de v. cava superior comprimeert.

Sjabloonzin voor het verslag

CT-thorax met contrast: Trachea en hoofdbronchi vrij. Geen actieve consolidatie in beide longen. [In de ...kwab een solide nodus van ... mm; follow-up volgens de nodusrichtlijn van jullie instelling geadviseerd.] Geen pleuravocht. Geen pathologisch vergrote mediastinale lymfeklieren. Geen lytische of sclerotische laesies in de afgebeelde ossale structuren.

CT-pulmonalisangiografie

CT *Verdenking longembolie.*

1 · Vooraf

- Contrastkwaliteit: is er voldoende opacificatie van de truncus pulmonalis? Zo niet, vermeld dat in het verslag.
- Ademhalings- en bewegingsartefacten (vooral in de onderkwabben).
- Dunne coupes, MPR en MIP.
- Nierfunctie en het besluit over contrast liggen bij het klinische team; jij beschrijft de diagnostische kwaliteit.

2 · Daarna

1. **Truncus pulmonalis → rechts en links → lobair → segmentaal → subsegmentaal:** volg elke tak in volgorde.
2. **Vullingsdefect:** acuut (centraal, vat verwijd, scherpe hoek) of chronisch (excentrisch, wandstandig, web/band, vat vernauwd).
3. **Rechterhartbelasting:** RV/LV-ratio, afvlakking of naar links uitbollen van het interventriculaire septum, contrastreflux naar de VCI en de levervenen.
4. **Parenchym:** wigvormig infarct met pleurale basis, mozaïekperfusie.
5. **Pleuravocht.**
6. **Differentiaaldiagnosen:** pneumonie, dissectie, pneumothorax, pericardvocht, massa.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Onderkwabarteriën (hier zijn bewegingsartefacten het grootst).
- [ ] Subsegmentale takken.
- [ ] Rechterventrikel en septum.
- [ ] Staat de contrastkwaliteit in het verslag?

Rode vlaggen · direct melden

Embolie in de centrale of hoofdtak van de a. pulmonalis · tekenen van rechterhartbelasting · alternatieve kritieke diagnose (dissectie, pneumothorax).

Sjabloonzin voor het verslag

CT-pulmonalisangiografie: De opacificatie van de longarteriën is diagnostisch voldoende. In de [rechter/linker] [lobaire/segmentale] takken van de a. pulmonalis zijn vullingsdefecten zichtbaar, passend bij acute longembolie. RV/LV-ratio ...; septumafvlakking [aanwezig/afwezig]. Conclusie: Acute longembolie. Bevinding om ... uur telefonisch doorgegeven aan ....

CT abdomen-bekken

CT *Acute buikpijn, appendicitis, diverticulitis, obstructie, perforatie, massa.*

1 · Vooraf

- Fase(n): blanco, arterieel, portaal-veneus, laat; is er oraal contrast?
- Verduidelijk de klinische vraag (plaats van de pijn, koorts, operatieve voorgeschiedenis).
- Vensters: weke delen, longvenster voor de longbases, breed venster voor vrij lucht, botvenster.

2 · Daarna

1. **Longbases.**
2. **Lever,** galblaas en galwegen.
3. **Milt, pancreas, bijnieren.**
4. **Nieren, ureteren, blaas.**
5. **Tractus digestivus:** volg van maag tot rectum (wand, kaliber, appendix).
6. **Mesenterium en peritoneum:** vrij vocht, vrij lucht, vetinfiltratie.
7. **Vaten:** aorta, truncus coeliacus en mesenteriale arteriën, portaal systeem.
8. **Lymfeklieren:** retroperitoneaal, mesenteriaal, pelvien.
9. **Bekkenorganen.**
10. **Buikwand en hernia's; botten.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Is de appendix gevonden?
- [ ] Herniapoorten (inguinaal, femoraal, umbilicaal, littekenbreuk).
- [ ] Vrij lucht (in breed venster).
- [ ] Mesenteriale vaten.
- [ ] Botten en longbases.

Rode vlaggen · direct melden

Vrij lucht · tekenen van mesenteriale ischemie (pneumatosis, gas in de v. portae, verlies van wandaankleuring) · strangulatie · geruptureerd AAA · actieve contrastextravasatie.

Sjabloonzin voor het verslag

CT abdomen-bekken met contrast (portaal-veneuze fase): Lever, milt, pancreas, bijnieren en nieren zonder bijzonderheden. Appendix [zichtbaar; diameter en omgeving zonder bijzonderheden]. Geen vrij vocht of vrij lucht. Normaal darmkaliber. Geen pathologisch vergrote lymfeklieren. Conclusie: Geen acute abdominale pathologie.

Total body CT bij trauma

CT *Multitrauma, hoogenergetisch mechanisme.*

1 · Vooraf

- Ken het protocol: schedel en cervicale wervelkolom zonder contrast; thorax-abdomen-bekken met contrast (arterieel en portaal-veneus of split bolus).
- Hemodynamische toestand van de patiënt.
- Beoordeel in twee fasen: eerst een snelle primaire beoordeling op levensbedreigende bevindingen met mondelinge eerste melding, daarna een uitgebreide secundaire beoordeling.

2 · Daarna

1. **Schedel:** bloeding met massa-effect, herniatie.
2. **Cervicale wervelkolom:** alignment, fractuur.
3. **Thorax:** spanningspneumothorax, massale hematothorax, aortaletsel, pericardvocht.
4. **Abdomen:** hemoperitoneum, laceratie van solide organen, actieve extravasatie.
5. **Bekken:** ringfractuur, hematoom, actieve bloeding.
6. **Thoracolumbale wervelkolom:** fractuur en instabiliteit.
7. **Positie van tubes en lijnen.**
8. **Secundaire beoordeling:** aangezichtsschedel, extremiteiten, darm-mesenterium, diafragma, nieren en blaas.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Diafragma (ruptuur).
- [ ] Darm en mesenterium (denk eraan bij vrij vocht zonder letsel van solide organen).
- [ ] Pancreas en duodenum.
- [ ] Blaas (eventueel late fase nodig).
- [ ] Ribben, scapula, sternum en de afgebeelde extremiteiten.

Rode vlaggen · direct melden

Intracraniële bloeding met massa-effect · aortaletsel · spanningspneumothorax · actieve bloeding · instabiele bekken- of wervelfractuur.

Sjabloonzin voor het verslag

Total body CT bij trauma — eerste melding (... uur): [Levensbedreigende bevindingen]. Uitgebreid verslag: Schedel: [...]. Cervicale wervelkolom: [...]. Thorax: [...]. Abdomen-bekken: [...]. Wervelkolom: [...]. Extremiteiten: [...]. Bevindingen om ... uur doorgegeven aan het traumateam.

CT-nierstenenprotocol

CT *Verdenking nierkoliek, follow-up van urinewegstenen.*

1 · Vooraf

- Low-dose onderzoek zonder contrast.
- Dekking van de nieren tot en met de blaasbodem.
- Coronale reconstructies.
- Eerdere onderzoeken en bekende stenen in de voorgeschiedenis.

2 · Daarna

1. **Nieren:** concrement, hydronefrose, perirenale vetinfiltratie, parenchym.
2. **Volg de ureter coupe voor coupe:** pyelo-ureterale overgang, kruising met de iliacale vaten en ureterovesicale overgang (nauwe passages).
3. **Concrement:** grootste diameter, lokalisatie (proximale, middelste, distale ureter, UVJ).
4. **Secundaire bevindingen:** hydro-ureteronefrose, periureterale vetinfiltratie, vergrote nier.
5. **Wat op een concrement lijkt:** flebolieten (rond, vaak met centrale radiolucentie), vaatverkalkingen; een wekedelenring rond het concrement (oedemateuze ureter) pleit voor een steen.
6. **Blaas.**
7. **Differentiaaldiagnosen:** appendicitis, diverticulitis, adnexpathologie, aneurysma van de abdominale aorta.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Ureterovesicale overgang (steen bij de blaasingang).
- [ ] Contralaterale nier.
- [ ] Appendix en aorta.
- [ ] Staan de differentiaaldiagnosen in het verslag?

Rode vlaggen · direct melden

Concrement en obstructie met tekenen van infectie (verdenking pyonefrose) · obstructie bij een mononier · bilaterale obstructie · perirenaal vocht (fornixruptuur) · AAA.

Sjabloonzin voor het verslag

Blanco CT (nierstenenprotocol): In de [rechter/linker] distale ureter, ter hoogte van de UVJ, een concrement van ... mm met proximaal [lichte/matige] hydro-ureteronefrose en periureterale vetinfiltratie. Contralaterale nier [...]. Geen alternatieve acute pathologie.

MRI-hersenen

MRI *Acuut neurologisch beeld, massa, infectie, demyeliniserende ziekte, insult.*

1 · Vooraf

- Herken de sequenties: T1, T2, FLAIR, DWI en ADC, SWI of GRE, T1 met contrast.
- Vlakken (axiaal, coronaal, sagittaal).
- Is er contrast gegeven?
- Eerdere onderzoeken en klinische vraag.

2 · Daarna

1. **DWI/ADC:** acute ischemie, abces, hypercellulaire laesie (DWI helder + ADC donker = restrictie).
2. **FLAIR:** wittestoflaesies, sulcale hyperintensiteit (SAB, meningitis), oedeem.
3. **T2:** Liquorruimten, flow voids van de vaten.
4. **T1:** stadium van een bloeding, vet, laesies die al vóór contrast hoog signaal hebben.
5. **SWI/GRE:** microbloedingen, verkalkingen.
6. **T1 met contrast:** aankleurende laesie, meningeale aankleuring.
7. **Middenlijn:** corpus callosum, hypofyse, hersenstam; ventrikels en cisternen.
8. **Fossa posterior** en craniocervicale overgang (tonsillen).
9. **Buiten de schedel:** orbitae, sinussen, mastoïden, beenmerg van het calvarium.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Hypofyse en sella.
- [ ] Brughoek en inwendige gehoorgangen.
- [ ] Craniocervicale overgang.
- [ ] Durale veneuze sinussen (trombose).
- [ ] Orbitae en beenmerg van de schedel.

Rode vlaggen · direct melden

Acuut infarct · abces · massa-effect of herniatie · sinustrombose.

Sjabloonzin voor het verslag

MRI-hersenen met contrast: Op de diffusiegewogen opnamen geen diffusierestrictie passend bij acute ischemie. Geen pathologische signaalveranderingen of aankleuring in het supra- en infratentoriële parenchym. Ventrikelsysteem en cisternen zonder bijzonderheden. Middenlijnstructuren in de middenlijn. Conclusie: Geen evidente intracraniële pathologie.

MRI lumbale wervelkolom

MRI *Lage rugpijn en radiculopathie, verdenking caudasyndroom, verdenking infectie of metastase.*

1 · Vooraf

- Sequenties: sagittaal T1, T2, STIR; axiaal T2; is er contrast?
- Niveaubepaling: stel L5–S1 met zekerheid vast; is er een overgangswervel, vermeld dan in het verslag hoe je hebt geteld.
- Kliniek: welke wortel, welke zijde?

2 · Daarna

1. **Alignment:** spondylolisthesis.
2. **Wervellichamen:** beenmergsignaal (op T1 helderder dan de discus), fractuur, oedeem (STIR).
3. **Disci:** hydratie, hoogte, bulging, protrusie, extrusie, sekwestratie.
4. **Axiaal op elk niveau:** centraal kanaal, laterale recessus, neuroforamina.
5. **Conus medullaris:** niveau en signaal; wortels van de cauda equina.
6. **Facetgewrichten** en ligamentum flavum.
7. **Paravertebrale weke delen.**
8. **Afgebeeld retroperitoneum:** nieren, aorta.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Conus medullaris.
- [ ] Sacrum en sacro-iliacale gewrichten.
- [ ] Foraminale en extraforaminale (laterale) hernia's.
- [ ] Focale laesie in het beenmerg (metastase).
- [ ] Retroperitoneale bevindingen.

Rode vlaggen · direct melden

Compressie van de cauda equina · spondylodiscitis of epiduraal abces · metastase en pathologische fractuur · compressie van de conus.

Sjabloonzin voor het verslag

MRI lumbale wervelkolom: Lumbale lordose behouden. Wervellichaamhoogten en beenmergsignaal zonder bijzonderheden. L4-L5: [rechts/links] paramediane discusprotrusie die de laterale recessus vernauwt en de [rechter/linker] L5-wortel comprimeert. L5-S1: [...]. De conus medullaris eindigt ter hoogte van L1 en heeft een normaal signaal.

MRI-knie

MRI *Instabiliteit van de knie na trauma, slotklachten, verdenking band- of meniscusletsel.*

1 · Vooraf

- Sequenties: PD met vetsuppressie (drie vlakken), T1, zo nodig T2.
- Zijde en klinische vraag (instabiliteit, slotklachten, plaats van de pijn).
- Eerdere operatie (reconstructie, meniscectomie).

2 · Daarna

1. **Mediale meniscus:** voorhoorn, corpus, achterhoorn, wortel.
2. **Laterale meniscus:** in dezelfde volgorde.
3. **VKB.**
4. **AKB.**
5. **Collaterale banden:** MCL; laterale complex (LCL, bicepspees, popliteus).
6. **Strekapparaat:** quadriceps- en patellapees, retinacula.
7. **Kraakbeen:** patellofemoraal, mediaal en lateraal compartiment.
8. **Beenmerg:** contusiepatroon, fractuur, osteonecrose.
9. **Gewrichtsvocht,** Bakercyste, plica, weke delen.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Meniscuswortels (posterieure wortelscheur).
- [ ] Verplaatst meniscusfragment in de fossa intercondylaris.
- [ ] Posterolaterale hoek.
- [ ] Mediale patellaire retinaculum (na patellaluxatie).
- [ ] Welk bandletsel doet het contusiepatroon vermoeden?

Rode vlaggen · direct melden

Occulte tibiaplateaufractuur · multiligamentair letsel na knieluxatie (vasculaire beoordeling) · verdenking tumor.

Sjabloonzin voor het verslag

MRI van de [rechter/linker] knie: Volledige ruptuur van de VKB. Beenmergoedeem (contusie) in de laterale femurcondyl en het posterolaterale tibiaplateau. Scheur in de achterhoorn van de mediale meniscus tot aan het onderoppervlak. AKB, collaterale banden en strekapparaat intact. Hydrops van het gewricht.

Echo abdomen (bovenbuik)

Echo *Pijn rechtsboven in de buik, icterus, verhoogde leverenzymen, verdenking galstenen.*

1 · Vooraf

- Nuchter (voor beoordeling van de galblaas).
- Convexe probe; diepe inspiratie en linkerzijligging helpen.
- Gain- en diepte-instelling; klinische vraag.

2 · Daarna

1. **Lever:** grootte, contour, echogeniciteit, focale laesie.
2. **Levervenen en v. portae:** zo nodig flow met doppler.
3. **Galblaas:** stenen, sludge, wanddikte, pericholecystitisch vocht, sonografische Murphy.
4. **Galwegen:** intrahepatische dilatatie, diameter van de ductus choledochus.
5. **Pancreas:** kop, corpus, staart (darmgas kan beperken; vermeld de beperking).
6. **Milt.**
7. **Nieren.**
8. **Aorta en VCI.**
9. **Vrij vocht** en pleuravocht basaal.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Leverkoepel (onder het diafragma).
- [ ] Linker leverkwab.
- [ ] Galblaashals (ingeklemde steen).
- [ ] Pancreasstaart.
- [ ] Morison-pouch en pleurasinussen.

Rode vlaggen · direct melden

Gecompliceerde acute cholecystitis · galwegdilatatie met koorts (verdenking cholangitis) · onverklaard vrij vocht · AAA.

Sjabloonzin voor het verslag

Echo bovenbuik: Lever van normale grootte, gladde contour, homogeen parenchym; geen focale laesie. Galblaas normaal gevuld, normale wanddikte; geen stenen. Intra- en extrahepatische galwegen niet verwijd. Pancreas, milt en afgebeelde nieren zonder bijzonderheden. Geen vrij vocht.

Echo nieren-blaas

Echo *Nierkoliek, urineweginfectie, verminderde nierfunctie, hematurie, urineretentie.*

1 · Vooraf

- De blaas moet gevuld zijn.
- Breng beide nieren in beeld in de lange en de korte as.
- Convexe probe; kleurendoppler klaar.

2 · Daarna

1. **Niergrootte** (lange as) en contour.
2. **Parenchymdikte en echogeniciteit** (in vergelijking met lever en milt).
3. **Corticomedullaire differentiatie.**
4. **Pyelocalicieel systeem:** hydronefrose en de graad ervan.
5. **Concrement:** akoestische schaduw; twinkling-artefact op kleurendoppler.
6. **Cyste en massa:** simpel, complex of solide?
7. **Ureteren:** proximale en distale delen, als ze zichtbaar zijn.
8. **Blaas:** wand, concrement, massa, divertikel; ureterjets met doppler.
9. **Residu na mictie** (indien gevraagd).
10. **Afgebeelde prostaat of uterus.**

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Contralaterale nier.
- [ ] Boven- en onderpool.
- [ ] Blaasbodem en ureterovesicale overgang (distaal concrement).
- [ ] Cyste of hydronefrose (is er verbinding)?
- [ ] Perirenaal vocht.

Rode vlaggen · direct melden

Pyonefrose (echogene inhoud in het pyelocaliciële systeem) · obstructie bij een mononier · bilaterale hydronefrose en urineretentie · solide niermassa.

Sjabloonzin voor het verslag

Echo nieren-blaas: Beide nieren hebben een normale grootte en ligging; parenchymdikte en echogeniciteit zonder bijzonderheden. In de [rechter/linker] nier is [lichte] pyelocalicele ectasie zichtbaar; geen concrementen. Blaas gevuld, wand glad; geen intraluminale afwijkingen.

eFAST

Echo / POCUS *Snelle bedside beoordeling van vrij vocht, pericardvocht en pneumothorax bij een traumapatiënt.*

1 · Vooraf

- Hemodynamische toestand; tijdstempel (eFAST wordt herhaald en vergeleken).
- Convexe probe (subxifoïdaal voor het pericard); voor de pleura kan ook een lineaire probe.
- Patiënt in rugligging; snel en elke keer in dezelfde volgorde.

2 · Daarna

1. **Rechterbovenkwadrant:** Morison-pouch, onderpool van de lever (het meest gevoelige punt), rechter subfrenische ruimte, rechter pleurasinus.
2. **Linkerbovenkwadrant:** rondom de milt en de subfrenische ruimte (vocht verzamelt zich hier het eerst), splenorenale ruimte, linker pleurasinus.
3. **Bekken:** achter de blaas (lange en korte as).
4. **Subxifoïdaal:** pericardvocht.
5. **Bilateraal anterieure thorax:** pleurasliding, B-lijnen, lung point (pneumothorax).

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Onderpool van de lever.
- [ ] Rondom de milt en de subfrenische ruimte.
- [ ] Pleurasinussen (hematothorax).
- [ ] Pericard.
- [ ] Een negatieve eFAST sluit letsel niet uit: herhaal bij klinische verandering of adviseer een CT.

Rode vlaggen · direct melden

Positieve FAST bij hemodynamische instabiliteit · pericardvocht (verdenking tamponade) · afwezige sliding en lung point (pneumothorax).

Sjabloonzin voor het verslag

eFAST (... uur): Morison-pouch: [wel/geen vocht]. Splenorenaal: [wel/geen vocht]. Pelvien: [wel/geen vocht]. Pericard: [wel/geen vocht]. Rechter hemithorax: pleurasliding [aanwezig/afwezig], vocht [aanwezig/afwezig]. Linker hemithorax: [...]. Conclusie: [positief/negatief/onbeslist]. Een negatieve eFAST sluit intra-abdominaal letsel niet uit.

Longecho

Echo / POCUS *Bedside beoordeling bij dyspneu: pneumothorax, oedeem, consolidatie, effusie.*

1 · Vooraf

- Probe: lineair voor de pleura, convex of sector voor diepere structuren.
- Het protocol dat je gebruikt en de scanzones (voor, zijkant en posterolateraal per hemithorax).
- Positie van de patiënt; M-mode klaar.

2 · Daarna

1. **Pleuralijn:** glad, verdikt of onregelmatig?
2. **Pleurasliding:** In M-mode het normale «seashore»-beeld, bij afwezige sliding het «barcode»-beeld.
3. **A-lijnen:** normale horizontale artefacten van beluchte long.
4. **B-lijnen:** aantal en verdeling (focaal of diffuus).
5. **Lung point:** het punt waar glijdende en niet-glijdende long elkaar raken; specifiek voor pneumothorax.
6. **Consolidatie:** weefselachtig aspect (hepatisatie), dynamische luchtbronchogrammen.
7. **Effusie:** anechogeen gebied boven het diafragma, wervelkolom zichtbaar boven het diafragma, long die in het vocht beweegt.
8. **Lung pulse:** pleurabeweging met de hartslag bij afwezige sliding (helpt pneumothorax uit te sluiten).

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Posterolaterale basale punten aan beide zijden (effusie en consolidatie).
- [ ] Bij verdenking op pneumothorax de hoogste (anterieure) punten.
- [ ] Staan het aantal gescande zones en het protocol in het verslag?

Rode vlaggen · direct melden

Afwezige sliding en lung point (pneumothorax) · grote effusie · diffuus B-patroon met hypoxie.

Sjabloonzin voor het verslag

Longecho (... zones): Bilateraal in de anterieure zones is pleurasliding aanwezig, met een A-patroon. In de [rechter/linker] posterolaterale basale zone zijn een consolidatie en een geringe hoeveelheid pleuravocht zichtbaar. Geen aanwijzingen voor een pneumothorax.

Veneuze duplex onderste extremiteit

Echo / doppler *Eenzijdige beenzwelling en pijn, verdenking diepe veneuze trombose.*

1 · Vooraf

- Lineaire probe.
- Positie voor vulling van de venen: hoofdeinde omhoog of zittend; voor de knieholte de knie licht gebogen.
- Protocol van je instelling: alleen proximaal, of inclusief kuitvenen?
- Klinische zijde.

2 · Daarna

1. **V. femoralis communis:** compressie in transversale doorsnede.
2. **Saphenofemorale overgang.**
3. **V. femoralis** : over het hele verloop intermitterend comprimeren (de vroeger zogenoemde «v. femoralis superficialis» is een **diepe** vene).
4. **V. poplitea:** tot aan de trifurcatie.
5. **Kleuren- en spectrale doppler:** respiratoire fasiciteit (verlies wijst op proximale obstructie) en augmentatie.
6. **Kuitvenen** (volgens protocol).
7. **Spectraal signaal in de contralaterale v. femoralis communis** (ter vergelijking).
8. **Differentiaaldiagnosen:** Bakercyste, hematoom, lymfeklier, cellulitis, oedeem.

3 · Voordat je afsluit

- [ ] Adductorenkanaal (compressie van de v. femoralis is hier lastig).
- [ ] Gedupliceerde v. femoralis.
- [ ] Fossa poplitea.
- [ ] Is de respiratoire fasiciteit beoordeeld?
- [ ] Staan de niet-beoordeelbare segmenten in het verslag?

Rode vlaggen · direct melden

Proximale DVT · verdenking uitbreiding van de trombus naar de v. iliaca of de VCI · uitgebreide trombose met ernstige zwelling en verkleuring.

Sjabloonzin voor het verslag

Veneuze duplex van het [rechter/linker] been: De v. femoralis communis, v. femoralis en v. poplitea zijn volledig comprimeerbaar en het lumen vult volledig op kleurendoppler; spectraal zijn respiratoire fasiciteit en een augmentatierespons aanwezig. Conclusie: Geen aanwijzingen voor diepe veneuze trombose.

LAATSTE CONTROLE

Bij elk onderzoek, vóór het ondertekenen

Stel jezelf deze vijf vragen voordat je een verslag afsluit, welk onderzoek het ook is.

Vijf vragen

- [ ] Juiste patiënt, juiste datum, juiste zijde?
- [ ] Heb ik de klinische vraag duidelijk beantwoord?
- [ ] Heb ik vergeleken met het vorige onderzoek en de verandering beschreven?
- [ ] Heb ik gekeken naar de blinde vlekken uit de lijst «Voordat je afsluit»?
- [ ] Heb ik een spoedbevinding doorgegeven en de melding met tijdstip in het verslag gezet?

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Cadeau 1 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen. Je ziet de normale en pathologische beelden van de bevindingen die je in de volgorde van deze gids doorloopt naast elkaar.

Om bevindingen in de juiste woorden te beschrijven, ga je daarna verder met **Cadeau 4 · Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag**.